5.鉴别诊断

	原发性高血压	慢性肾炎 起始部位在肾小球
发生顺序	先有高血压再有肾病	先有肾病再有高血压
高血压程度	较重	较轻或较重
肾损害程度	远曲小管功能损害（尿浓缩功能↓、夜尿、低比重尿）较肾小球损害早（血供丰富）	肾小球损害程度重（血尿、蛋白尿、少尿明显）
好发年龄	中老年	青壮年
靶器官损害	多见（心、脑、眼底等病变）	少见（若出现提示病情重）

专题串联·原发性肾小球疾病的常考病例题

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.**金标准：穿刺活检** 只有看病理学类型才能知道到底是哪种疾病

2.IgA 肾病

可能可能最可能：1-3 **天**感染病史，随后明显**血尿** 我国肾小球源性血尿最常见的原因

多种病理类型，以**系膜增生性肾炎**最常见（系膜细胞和基质增生）

系膜区-没有基底膜封闭

3.隐匿性肾炎（考概念）

可能可能最可能：无症状性血尿和/或蛋白尿（**无水肿、高血压、肾功能损害**，仅血尿/仅蛋白尿/仅血尿+蛋白尿）

定期随访，**不**用激素+环磷酰胺

4.急性肾炎综合征 先用利尿剂消肿降压;再用ACEI/ARB降尿蛋白,保护肾单位;出现高血压急症-硝普钠

可能可能最可能：**血尿/＞3/HP（必备且突出）**、蛋白尿（可轻可重）、水肿和高血压（**GFR↓致水钠潴留**→水肿多从**眼睑颜面部开始**憋出来的）

容量依赖型高血压

急性肾炎	急进性肾炎
1-3 周感染病史，急性肾炎综合征	
Cr 多＜200、贫血多无或轻	**Cr＞200、贫血有甚至中度及以上** 肾功能恶化严重
C_3↓且 8 周内恢复（特点）	“好严重急性肾炎的感觉”C_3 II型持续↓循环免疫复合物
内皮和系膜细胞增生（毛细血管内增生性肾炎） **驼峰状**电子致密物（内坨）	肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成**新月体** （毛细血管外增生性肾炎）闭月

脂性肾病、膜性肾病(唯二的2病没有新月体的病理特点
没有急进性肾炎综合征的临床表现)

急进性肾炎：

I抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型：**原位**免疫复合物、**线状荧光**（一线妓院大换血）

II免疫复合物型：原位或循环、**颗粒状荧光、电子致密物**

III免疫反应缺乏型：中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA**、**无荧光**（3 型安卡无免疫）

5.**间断水肿** 病程长

不一定会同时出现

（1）**慢性肾炎**：慢性肾炎综合征（血尿、蛋白尿、水肿、高血压迁延不愈、隐匿），**双肾体积早期正常、后期对称缩小（B 超＜10cm）**。肾小球纤维化、玻璃样变性、**继发性颗粒性固缩肾**

一开始是肾小球的问题,后期可以累及肾小管

VS 慢性肾盂肾炎:肾脏不对称缩小,一开始是肾小管的问题